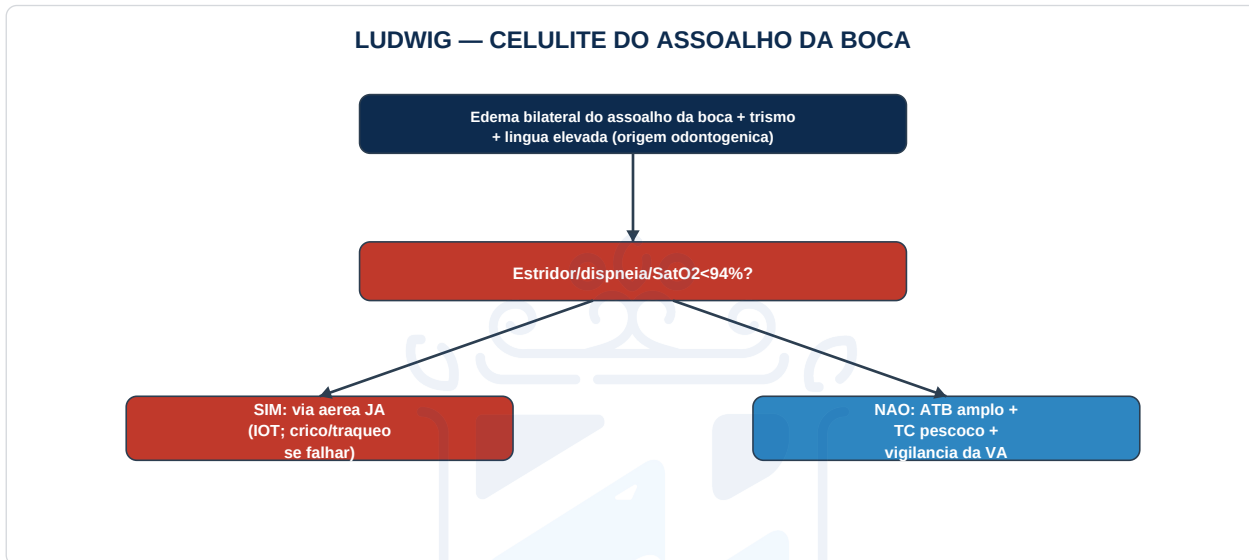


ANGINA DE LUDWIG — VIA AÉREA É PRIORIDADE

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA DE VIA AÉREA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Celulite GRAVE dos tecidos moles dos espaços submandibular e sublingual, de origem ODONTOGÊNICA
- Risco de rápida progressão para obstrução de via aérea, sepse e extensão cervical/mediastinal
- É celulite difusa (não coleção delimitada inicialmente) — por isso a ênfase em via aérea e ATB
- Emergência: o tempo de progressão é curto

QUANDO SUSPEITAR — SINAIS DE ALERTA

QUADRO CLÁSSICO

- Dor facial/bucal intensa + edema BILATERAL do assoalho da boca
- Trismo (limitação da abertura oral)
- Disfagia / odinofagia
- Elevação e fixação da língua ao palato
- Dificuldade para deglutir saliva ou voz abafada
- Dispneia ou ESTRIDOR inspiratório = risco imediato de via aérea comprometida

ESTRATIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Gravidade	Características
Alta	Estridor, SatO2 < 94%, edema de rápida progressão, sinais de sepse
Moderada	Edema importante, trismo, dor intensa, mas saturação e respiração preservadas
Leve	Edema discreto, sem comprometimento importante da via aérea

RED FLAGS — VIA AÉREA (PRIORIDADE 1)

QUALQUER SINAL DE VA COMPROMETIDA = URGÊNCIA ABSOLUTA

- Estridor inspiratório, dispneia, queda de saturação
- Garantir via aérea com segurança ANTES de qualquer outra etapa
- Em obstrução iminente: intubação (preferir via aérea avançada planejada / acordada)
- Se IOT falhar ou for inviável: cricotireoidostomia ou traqueostomia de emergência
- Reavaliar a via aérea continuamente — pode deteriorar rapidamente

EXAMES

COMPLEMENTARES (sem atrasar a via aérea)

- TC de pescoço com contraste: extensão das coleções, regiões envolvidas, abscessos drenáveis
- Laboratório: hemograma, PCR, função renal, eletrólitos, glicemia
- Culturas (sangue e secreções) quando possível
- Imagem NÃO deve preceder a estabilização da via aérea em paciente instável

ANTIBIOTICOTERAPIA E SUPORTE

Rx COBRIR FLORA ORAL POLIMICROBIANA

Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6-8h, OU

Meropenem 1g IV 8/8h, OU

Cefepime 2g IV 12/12h + Metronidazol 500mg IV 8/8h

Adicionar Vancomicina 15-20 mg/kg IV 8-12h se risco de MRSA

Duração inicial 14-21 dias (ajustar pela evolução)

Suporte: internação em UTI/semi, hidratação, analgesia, correção eletrolítica, suporte nutricional

CONTROLE CIRÚRGICO DO FOCO

DRENAGEM / TRATAMENTO DENTÁRIO

- Drenagem imediata se: abscesso colecionável ou tecido necrótico
- Ausência de melhora em 24-48h apesar de ATB adequado
- Extensão cervical profunda ou mediastinite
- Incisão e drenagem dos espaços comprometidos + drenos
- Tratar o foco primário: extração/endodontia do dente causal assim que possível

MONITORIZAÇÃO E SINAIS DE ALARME

VIGIAR

- ☐ Sinais vitais contínuos, saturação e trabalho respiratório
- ☐ Sinais de sepse/choque e progressão do edema
- ☐ Deterioração neurológica ou hemodinâmica -> reavaliar via aérea imediatamente
- ☐ Resposta ao ATB e necessidade de drenagem em 24-48h
- ☐ Glicemia (diabéticos têm pior evolução)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA (SAMU)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com Angina de Ludwig (edema bilateral submandibular/sublingual, língua elevada, trismo), gravidade ____.
- Via aérea: ____ (pérvia / IOT / crico-traqueo). SatO2 ____ | sinais de sepse: sim/não.
- ATB amplo iniciado às ____; TC de pescoço: ____; Foco dentário: ____.
- Solicito UTI móvel / vaga em serviço com cirurgia de cabeça e pescoço (risco iminente de via aérea).



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com edema bilateral do assoalho da boca, língua elevada, trismo e agora estridor inspiratório. Qual a prioridade absoluta?

- A) Solicitar TC de pescoço antes de tudo
- B) Garantir a via aérea (IOT; se falhar, cricotireoidostomia/traqueostomia)
- C) Iniciar apenas antibiótico oral
- D) Aguardar avaliação odontológica eletiva
- E) Prescrever corticoide e dar alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a origem mais comum da Angina de Ludwig?

- A) Infecção odontogênica
- B) Otite média
- C) Sinusite frontal
- D) Infecção urinária
- E) Pneumonia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual esquema antibiótico empírico é adequado para a Angina de Ludwig (flora oral polimicrobiana)?

- A) Azitromicina oral isolada
- B) Piperacilina-tazobactam IV (ou meropenem; ou cefepime + metronidazol), com vancomicina se risco de MRSA
- C) Apenas metronidazol oral
- D) Ciprofloxacino oral
- E) Nenhum antibiótico, só drenagem

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado classifica a Angina de Ludwig como de ALTA gravidade?

- A) Edema discreto sem dispneia
- B) Estridor, SatO₂ < 94%, edema de rápida progressão ou sinais de sepse
- C) Apenas trismo leve
- D) Febre isolada
- E) Dor de garganta leve

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando indicar controle cirúrgico do foco na Angina de Ludwig?

- A) Nunca, o tratamento é exclusivamente clínico
- B) Abscesso colecionável/necrose, ausência de melhora em 24-48h ou extensão profunda/mediastinite, além de tratar o dente causal
- C) Somente após 21 dias de antibiótico
- D) Apenas se houver febre
- E) Somente em pacientes diabéticos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A Angina de Ludwig é primariamente uma emergência de via aérea. Diante de estridor/dispneia, a prioridade absoluta é assegurar a via aérea (IOT; cricotireoidostomia/traqueostomia se falhar), antes de imagem ou outras medidas.

QUESTÃO 2 → Resposta: A

A Angina de Ludwig é tipicamente de origem odontogênica (infecção dos molares inferiores), disseminando-se pelos espaços submandibular e sublingual de forma bilateral.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Cobre-se flora oral polimicrobiana (gram-positivos, anaeróbios e gram-negativos) com pipe-tazo, meropenem ou cefepime + metronidazol; adiciona-se vancomicina se houver risco de MRSA. Macrolídeo/quinolona oral isolados são insuficientes.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Alta gravidade = estridor, SatO₂ < 94%, edema de rápida progressão ou sinais de sepse — qualquer sinal de via aérea comprometida configura urgência absoluta.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Indica-se drenagem na presença de abscesso colecionável/necrose, falha clínica em 24-48h de ATB, ou extensão cervical profunda/mediastinite, sempre tratando o foco dentário primário assim que possível.

SM24
Suporte ao Plantão Médico